

HEMOPTISIS.

Paula Leonor Vilorio Vecino, Carlos Mier Bango, Rubén Escudero Gonzalez, Julio Tito Camino Acha, Emilio Antonio Santalla Valle.

INTRODUCCIÓN

Se define hemoptisis a la expulsión de sangre por la boca con la tos procedente del árbol traqueobronquial. La intensidad es muy variable, pudiendo aparecer desde un esputo teñido de sangre (esputo hemoptoico) hasta sangre pura (hemoptisis franca).

Clasificación

- **Hemoptisis no masiva:** no existe compromiso vital.
 - Esputo hemoptoico: 5 ml.
 - Hemoptisis leve: 30-50 ml/día.
 - Hemoptisis moderada: 30-150 ml/día
- **Hemoptisis masiva:** existe compromiso vital del paciente.
 - Hemoptisis grave: > 150 ml/día
 - Hemoptisis masiva: > 150 ml/día ó 600 ml/día.

Se debe tener en cuenta que cuantía exacta de la hemoptisis es difícil de concretar, puesto que los pacientes tienden a sobreestimarla, pero puede ser también subestimada, ya que parte de la sangre en algunos casos permanece retenida en el árbol traqueobronquial.

Etiología

- Infecciones y neoplasias: constituyen el grupo etiológico más frecuente, destacando la bronquitis crónica, las bronquiectasias, el carcinoma broncogénico, la neumonía bacteriana y la tuberculosis.
- Enfermedades cardiovasculares: TEP, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardiaca congestiva, rotura de aneurisma aórtico, estenosis mitral, etc.
- Traumatismos: rotura bronquial, contusión pulmonar, heridas penetrantes.
- Yatrogénicas: traqueotomías, cirugía torácica, broncoscopia, radioterapia.
- Otras: coagulopatías, pacientes sometidos a terapia anticoagulante, sarcoidosis, vasculitis, enfermedades autoinmunes e idiopáticas, cuerpos extraños endobronquiales, diátesis hemorrágica, etc.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

- En primer lugar hay que confirmar que se trata de una hemoptisis y cuantificarla, descartando que el sangrado proceda de la región oronasofaríngea y del tubo digestivo. La anamnesis es fundamental para realizar un correcto diagnóstico diferencial entre hemoptisis y hematemesis. La hemoptisis está producida por un acceso de tos y la sangre es roja y espumosa. Además puede presentar dolor costal y fiebre como clínica asociada. Por su parte, la hematemesis se produce tras vomitar y la sangre es negruzca, pudiendo presentar como cuadro clínico asociado náuseas, dolor abdominal o la existencia de melenas.
- Debe realizarse un examen de la cavidad oral y las fosas nasales a fin de confirmar que el sangrado es de origen subglótico, teniendo en cuenta que una epistaxis o una gingivorragia acontecidas durante la noche pueden parecer una falsa hemoptisis la mañana siguiente.
- Valoración de la gravedad: Resulta imprescindible cuantificar el sangrado.

- Si un paciente mayor de 40 años presenta síndrome constitucional y tabaquismo nos orientará a patología oncológica como el carcinoma de pulmón.
- Un paciente con antecedentes de infecciones respiratorias y broncorrea nos hará pensar en bronquiectasias.
- Antecedentes de tromboflebitis, inmovilización o dolor pleurítico nos pueden sugerir un TEP; mientras que ante la presencia de esputos pútridos deberemos descartar un absceso pulmonar.
- Se debe investigar acerca de los antecedentes de cardiopatía y el tratamiento habitual del paciente, como la toma de anticoagulantes.

Exploración física

- Constantes vitales: tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno.
- Inspección: valoración del estado general. Coloración de piel y mucosas. Presencia de tiraje intercostal y/o supraclavicular, ingurgitación yugular, acropaquias, etc.
- Palpación: búsqueda de adenopatías y signos de TVP y/o tromboflebitis.
- Auscultación cardiopulmonar: roncus, sibilancias, crepitantes, soplos, etc. La presencia de estertores unilaterales nos puede orientar acerca de la lateralidad del sangrado.
- Exploración ORL: descartar sangrados de origen supraglótico.

Pruebas Complementarias

- Hemograma, bioquímica básica y coagulación: orienta al diagnóstico de procesos infecciosos y puede proporcionar información acerca de la cuantía de la pérdida hemática.
- Pulsioximetría y gasometría arterial basal (cuando la saturación arterial de oxígeno sea inferior al 90%), incluso en ausencia de disnea.
- Radiografía posteroanterior y lateral de tórax: inespecífica hasta en un 50% de los casos. Puede detectar patologías como cavitaciones, hilios patológicos, bronquiectasias, derrames pleurales, quistes, nódulos, masas, etc.
- ECG
- Pruebas cruzadas si el paciente presenta hemoptisis masiva.
- Otras pruebas: si el paciente presenta criterios de ingreso se puede valorar la realización de otras pruebas más complejas como la broncoscopia y el TAC torácico.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Medidas generales:

- Canalización de vía venosa periférica en dos puntos con aguja de grueso calibre.
- Control de constantes vitales.
- Asegurar permeabilidad de la vía aérea y oxigenoterapia.
- Abstenerse de administrar aerosoles para evitar irritación.
- Tranquilizar al paciente.
- Corregir trastornos hemostáticos si están presentes

Medidas específicas en hemoptisis leve:

- Observación en urgencias durante 6-8 horas y alta a domicilio para completar estudio de forma ambulatoria. Se debe advertir al paciente que si aumenta el sangrado debe acudir de nuevo al servicio de urgencias.
- Tratamiento sintomático: Codeína 15 mg/6-8 horas si presenta tos, junto con reposo relativo.

- Tratamiento antibiótico: si se sospecha como desencadenante infección de las vías respiratorias. Se inicia tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro por vía oral (Amoxicilina-Clavulánico 875/125 mg/8 horas, Levofloxacino 500mg/24 horas, Claritromicina 500 mg/12 horas). Se debe evitar el uso de quinolonas hasta haber descartado TBC.
- Recomendar al paciente acudir al neumólogo para completar el estudio.

Medidas específicas en hemoptisis moderada. Se pasa a observación:

- Dieta absoluta para la realización posterior de broncoscopia.
- Reposo absoluto en decúbito lateral ipsilateral del lado de sospecha del sangrado.
- Sueroterapia.
- Control de constantes cada 6-8 horas, modificándose posteriormente según la situación hemodinámica del paciente.
- Cuantificación del sangrado.
- Cruzar y reservar sangre de forma urgente para una posible transfusión.
- Evitar la sedación farmacológica, tranquilizando al paciente en primera instancia.
- Codeína 30 mg/6 horas VO. Evitar si se observa mala función pulmonar.
- Antibioterapia de amplio espectro IV si sospecha de infección respiratoria.
- Oxigenoterapia si existe insuficiencia respiratoria.
- Beta adrenérgicos nebulizados y corticoides por vía IV si existe broncoespasmo asociado.
- Pantoprazol 40 mg cada 24 horas.
- En general, ingreso en planta para tratamiento y estudio.

Medidas específicas en hemoptisis masiva. Preservar las funciones vitales del paciente:

- Dieta absoluta.
- Monitorización continua de ECG, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
- Control horario de tensión arterial y diuresis.
- Reposo absoluto en cama en posición de Trendelenburg y en decúbito lateral ipsilateral al probable lado del sangrado, con el objeto de que el lado sano no se inunde de sangre y evitar así el edema pulmonar y la asfixia.
- Oxigenoterapia para mantener una $PaO_2 > 60\text{mmHg}$, con saturación de oxígeno $> 90\text{ mmHg}$.
- Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica o una vía venosa central, y administración de suero fisiológico, en una dosis inicial de 3.000 ml/24 h.
- Cruzar y reservar sangre de forma urgente para una posible transfusión.
- Intubación endotraqueal y respiración asistida si hay signos de insuficiencia respiratoria y/o hipercapnia y acidosis respiratoria.
- Tratamiento de las alteraciones de la coagulación, si se detectan.
- Antibioterapia si se sospecha infección respiratoria.
- Fibrobroncoscopia urgente, con valor diagnóstico y terapéutico.
- Ingreso en UCI.

Tabla I. Diagnóstico diferencial entre hemoptisis y hematemesis.

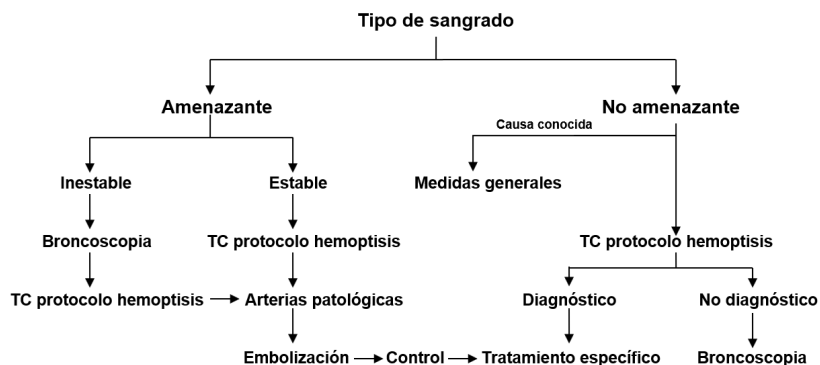
	HEMOPTISIS	HEMATEMESIS
Antecedentes	Enfermedad cardiorespiratoria	Enfermedad gastrointestinal
Síntomas	Tos, disnea, dolor torácico	Náuseas, vómitos, melenas
Aspecto de la sangre	Roja brillante, espumosa	Marrón/negra, posos de café
pH de la sangre emitida	Alcalino	Ácido
Otros componentes	Secreciones respiratorias	Restos alimenticios

	HEMOPTISIS	HEMATEMESIS
Anemia	Rara salvo hemoptisis	Frecuente
Confirmación	Broncoscopia	Endoscopia digestiva alta

Tabla II. Anamnesis en pacientes con hemoptisis.

Antecedentes	
Traumáticos	Manipulación diagnóstica sobre vía aérea/pulmón, traumatismo torácico, aspiración de cuerpo extraño
Inmovilización	
Contactos tóxicos	Tabaco, asbesto, productos químicos orgánicos
Fármacos	AINE, antiagregantes, anticoagulantes
Epidemiológicos	Viajes, contacto/riesgo TBC, parásitos
Familiares	Coagulopatía, ETEV, hemoptisis, aneurismas cerebrales
Comorbilidad	
Patología respiratoria	Criterios de bronquitis crónica, tos, expectoración, broncorrea, EPOC, bronquiectasias, neumonía, hemoptisis previa, neoplasia.
Otra patología	Cardiopatía, ETEV, inmunodepresión, enfermedad renal, digestiva, hematológica, autoinmune o sistémica.

Algoritmo de manejo de la hemoptisis:



Criterios de ingreso

Observación:

Pacientes con hemoptisis leve ocasional han de permanecer en observación durante un tiempo prudencial (6-8 horas) y, si se descartan otros criterios de ingreso, se puede dar de alta con tratamiento y remitir a su neumólogo.

Ingreso en planta de hospitalización

- Hemoptisis leve en la que se sospeche patología grave subyacente.
- Hemoptisis leve no ocasional sin etiología clara.
- Hemoptisis moderada sin inestabilidad hemodinámica.

Ingreso en UCI

- Hemoptisis masiva.
- Hemoptisis que precisen medidas de soporte vital avanzado.
- Hemoptisis con inestabilidad hemodinámica o respiratoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Rosa Cordovilla, Elena Bollo de Miguel, Ana Nuñez Ares, Francisco Javier Cosano Povedano, Inmaculada Herráez Ortega, Rafael Jiménez Merchán. Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento de la hemoptisis. SEPAR. Arch Bronconeumol 2016;52:368-77.
- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 6ª ed. Madrid: Elsevier; 2005.